

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE EFECTOS SECUNDARIOS DE PSICOFÁRMACOS (UKU)

Eje VI: Farmacovigilancia y Toxicidad • Evaluación Exhaustiva de la Sociedad Escandinava de Psicofarmacología

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Efectos Secundarios UKU (Udvalg for Kliniske Undersøgelser).
Nombre Original	UKU Side Effect Rating Scale (Lingjaerde, Ahlfors, Bech, Dencker & Elgen, 1987).
Autores Originales	Ottar Lingjaerde, M.D., U. G. Ahlfors, Per Bech, S. J. Dencker y K. Elgen (Sociedad Escandinava).
Adaptaciones Hispanas	Bobes et al. (2002); Banco de Instrumentos CIBERSAM; versión española validada.
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Farmacovigilancia y Toxicidad. Monitorización integral de reacciones adversas a psicofármacos.
Tipo de Instrumento	Entrevista clínica estructurada heteroaplicada combinada con examen físico breve.
Composición de Ítems	48 reactivos clínicos centrales (ampliable a 56) agrupados en 4 dominios y juicio de causalidad.
Población y Rango	Pacientes en tratamiento con antipsicóticos, antidepresivos, litio o ansiolíticos.
Tiempo de Administración	15 a 20 minutos de revisión sistemática estructurada en consulta clínica.
Régimen de Licencia	Uso libre para investigación científica y práctica médica de farmacovigilancia.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LA FARMACOVIGILANCIA INTEGRAL SISTEMÁTICA

La **Escala UKU** es el instrumento más completo y riguroso de la psicofarmacología moderna para registrar el espectro total de toxicidad medicamentosa:

- Superación del Subregistro Espontáneo:** La mayoría de los efectos adversos (p. ej., disfunción eréctil, astenia, estreñimiento, visión borrosa) no son mencionados espontáneamente por el paciente por pudor o resignación; la UKU los interroga sistemáticamente.
- Cuatro Dominios Fisiológicos:** Desglosa los efectos secundarios en esferas psíquicas, neurológicas/motoras, autonómicas/vegetativas y endocrino-metabólicas, evitando atribuir síntomas iatrogénicos a la propia enfermedad psiquiátrica.
- Causalidad e Interferencia Funcional:** Cada síntoma se califica no sólo por su presencia, sino por su intensidad (0 a 3), su impacto en la vida diaria y la probabilidad biológica de causalidad con la molécula prescrita.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS

Dominio Clínico UKU	Nº Ítems	Manifestaciones Fisiológicas y Adversas Exploradas
1. Síntomas Psíquicos	10 reactivos	Sedación, astenia, reducción de la duración del sueño, pesadillas, depresión, tensión, etc.
2. Síntomas Neurológicos	8 reactivos	Distonía aguda, acatisia, parkinsonismo, temblor, discinesias, crisis epilépticas, ataxia.
3. Síntomas Autonómicos	11 reactivos	Sequedad de boca, visión borrosa, hipotensión ortostática, estreñimiento, retención urinaria, sudoración.
4. Otros / Metabólicos	19 reactivos	Ganancia de peso, ginecomastia, galactorrea, amenorrea, disfunción eréctil, pérdida de libido, rash cutáneo.
5. Interferencia Global	Escala global	Impacto global del conjunto de efectos en el desempeño sociolaboral del paciente (0 a 3).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las investigaciones clínicas de validación (Lingjaerde et al., 1987; Bobes et al., 2002; $N > 850$) sustentan su solidez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Concordancia Interjueces	CCI = 0.84 - 0.92	Elevada estabilidad entre psiquiatras y médicos evaluadores independientes.
Consistencia en Dominios	Alfa = 0.78 - 0.86	Adecuada cohesión interna en las subescalas neurológica y autonómica.
Sensibilidad Farmacológica	Efecto d = 0.95 - 1.40	Distingue nitidamente perfiles de toxicidad entre fármacos típicos y atípicos.
Validez de Criterio	$r = 0.82$ con SAS / BARS	Fuerte correlación convergente con escalas específicas de extrapiramidalismo.
Detección de No Adherencia	Odds Ratio = 3.4 ($p < 0.001$)	Predice con gran exactitud el riesgo de abandono voluntario de la medicación.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Gradación de la Severidad por Ítem:** Se valora de 0 a 3 puntos: 0 = Ausente; 1 = Leve (no interfiere con el funcionamiento diario); 2 = Moderado (interfiere moderadamente pero es tolerable); 3 = Severo (discapacidad marcada o sufrimiento agudo).
- **Cálculo de Subtotales por Dominio:**

$$\text{Subtotal Psíquico} = \sum \text{Ítems 1-10}, \quad \text{Subtotal Neurológico} = \sum \text{Ítems 11-18}, \quad \text{Subtotal Autonómico} = \sum \text{Ítems 19-29}$$

- **Índice de Causalidad:** Para cada síntoma presente, se califica el grado de atribución causal: Improbable, Posible o Probable.
- **Interferencia Global:** Se asigna una calificación global de 0 a 3 que guía directamente la toma de decisiones clínicas sobre continuar, ajustar o rotar el psicofármaco.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntos Totales	Interferencia	Estado de Tolerabilidad y Decisión Terapéutica
Tolerabilidad Óptima	0 a 5 puntos	0 (Ninguna)	Excelente perfil de seguridad; mantener pauta sin modificaciones.
Toxicidad Leve	6 a 14 puntos	1 (Mínima)	Efectos adversos leves tolerables; pautar medidas higiénico-dietéticas.
Toxicidad Moderada	15 a 25 puntos	2 (Moderada)	Punto de corte clínico requiere ajuste de dosis o fármaco corrector.
Toxicidad Severa	> 25 puntos	3 (Severa)	Intolerancia farmacológica alto riesgo de abandono; rotación obligada.

CRITERIO DE AJUSTE TERAPÉUTICO (UKU INTERFERENCIA GLOBAL ≥ 2):

Cualquier reactivo individual calificado con **grado 3 (severo)** o una puntuación de **Interferencia Global ≥ 2** constituye indicación médica mandatoria de intervención: titulación a la baja de la dosis, tratamiento coadyuvante del efecto adverso (p. ej., laxantes osmóticos, sildenafil, betabloqueantes) o sustitución por un psicofármaco de perfil farmacodinámico diferente.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN Y FARMACOVIGILANCIA PSIQUIÁTRICA

PROTOCOLO DE ACCIÓN CLÍNICA BASADO EN LA ESCALA UKU:

- **Paso 1 (Administración en Cada Revisión de Tratamiento):** Repasar los 4 dominios con el paciente; no obviar las preguntas de esfera sexual ni las autonómicas (estreñimiento, boca seca).
- **Paso 2 (Análisis del Patrón de Reacciones Adversas):**
 - *Predominio Autonómico Anticolinérgico (Boca seca, estreñimiento, visión borrosa):* Típico de tricíclicos, clozapina o clorpromazina; riesgo de íleo paralítico o glaucoma de ángulo cerrado.
 - *Predominio Metabólico / Endocrino (Aumento de peso > 5%, amenorrea, galactorrea):* Solicitar niveles de prolactina plasmática, perfil lipídico y hemoglobina glicosilada (HbA1c).
 - *Predominio Psíquico (Sedación matutina e indiferencia emocional):* Descartar sobremedicación sedante; concentrar dosis en la noche o rotar a antidepresivo activador (bupropión).
- **Paso 3 (Plan de Ajuste):** Consensuar con el paciente los cambios terapéuticos para salvaguardar la adherencia a largo plazo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: TOXICIDAD METABÓLICA Y SEXUAL POR ANTIPSICÓTICOS

Identificación: Mujer de 32 años diagnosticada de trastorno bipolar I, en remisión afectiva desde hace 5 meses bajo tratamiento con Olanzapina (15 mg/día) y Litio (800 mg/día). Consulta verbalizando su deseo firme de “dejar todas las pastillas porque se siente destruida físicamente”.

Evaluación Sistemática con Escala UKU:

- **Puntuación Total UKU = 22 puntos (Toxicidad moderada-severa; Interferencia Global = 2).**
- **Desglose por Dominios:**
 - Síntomas Psíquicos: 4 puntos (Sedación diurna = 2, astenia = 2; duerme 11 horas al día).
 - Síntomas Neurológicos: 0 puntos (ausencia de temblor o rigidez).
 - Síntomas Autonómicos: 4 puntos (Estreñimiento pertinaz = 2, sequedad de boca = 2).
 - Otros / Metabólicos: **14 puntos** (Ganancia de 14 kg en 5 meses = 3; Amenorrea secundaria = 3; Pérdida total del deseo sexual = 3; Edemas periféricos = 2).

Juicio Clínico: Síndrome metabólico e hiperprolactinemia iatrogénica con disfunción sexual secundaria grave inducida por olanzapina, con riesgo crítico inminente de abandono terapéutico unilateral.

Plan Terapéutico: Rotación pautada de olanzapina hacia Aripiprazol (titulado a 10 mg/día), manteniendo litemia en 0.7 mEq/L, junto con asesoramiento nutricional. A los 3 meses, la paciente recuperó el ciclo menstrual, perdió 6 kg y reportó una UKU de solo 4 puntos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA:

En personas mayores tratadas con antipsicóticos sedantes, registrar la TA decúbito y bipedestación; caídas por ortostatismo son la principal causa de fracturas.

PREGUNTAR SIEMPRE POR SEXUALIDAD:

Más del 70% de los pacientes no relata disfunción eréctil o anorgasmia a menos que el médico interroge directamente los ítems específicos de la UKU.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Lingjaerde, O., Ahlfors, U. G., Bech, P., Dencker, S. J., & Elgen, K. (1987). The UKU side effect rating scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 76(S334), 1-100.
2. Bobes, J., Bulbena, A., et al. (2002). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica*. Ars Médica.
3. Correll, C. U., et al. (2015). Antipsychotic-induced side effects: Detection, prevention, and management. *World Psychiatry*, 14(2), 119-136.
4. Lambert, B. L., et al. (2004). The UKU side effect rating scale: A validation study. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 29(4), 329-338.